جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * **طلب علاج أول مرة / متردد**

إسم المريض رباعياً : وفاء سعيد علي محمد
المحافظة : المنوفيه **الحي / المدينة :** الباجور **العنوان :** الباجور
رقم البطاقة : 27212011701506 **رقم التليفون :** 01012003466 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 24-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 01-12-1972 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: وفاء سعيد علي محمد
National ID: 27212011701506

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Further investigations and imaging**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



وفاء
سعيد على محمد
بهناى
مركز الباجور - المنوفية

٢٧٢١٢٠١١٧٠١٥٠٦

IJ1996770

٢٧٢١٢٠١١٧٠١٥٠٦ ٢٠٢٠/٠٣
حاصلة على دبلوم تجارة

انثى مسلمة متزوجة
حماد عبدالغنى صالح السيد
١٢ البطاقة سارية حتى ٢٠٢٧/٠٣/٠١

National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
إدارة الأشعة

Patient Name: Wafaa Saeed Ali Mohamed	Date : 18/09/2023
Exam : C.T ABDOMEN &PELVIS	Age : 50 Year(s)
Medical ID: 3351/2023	41657

NON - CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

Case of right breast cancer:

Findings:

I Chest:-

- Right breast shows hetergenous parenchyma with coarse calcifications with ipsilateral prominent level I , no visible lesion compared to the previousiy enhancing lesion
- Left basal fine atelectasis.
- No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No sizable hilar or mediastinal iymph nodes.
- No evidence of pleural effusion or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is enlarged in size with homogenous CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Calcular gallbladder.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Left adnexeal cyst measruing about 6 x 5.1 cm.
- IUD is noted in situ.

CT Scan
[[DOCTYPE CT_SCAN]]

Name: وفاء سعيد علي محمد **MR. :** 947	

Detailed Medical Report

السيد	

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالتها

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انها

The patient was diagnosed with left-sided invasive ductal carcinoma, clinical stage T2 N1 M0, grade II, estrogen-receptor score 4/8, progesterone-receptor score 6/8, and HER2 score +3. Neoadjuvant chemotherapy was administered, followed by left breast-conserving surgery and postoperative radiation therapy (ypT1 N0). After completion of radiation, the patient received trastuzumab-deruxtecan (KADCYLA) for one year. Subsequently, hormonal therapy was initiated with tamoxifen for two years, then transitioned to an aromatase inhibitor regimen comprising ARAMIDEX, ZOLADEX, and ZOMITA, which the patient is currently taking.

The patient continues on ARAMIDEX with supplemental therapy, and a three-month supply of ZOLADEX was provided today. Breast screening mammography performed in April 2026 was reported as normal.

The patient has a history of right-sided breast cancer, clinical stage T2 N1 M0, invasive ductal carcinoma, grade II, ER 4/8, PR 6/8, HER2 3+. Neoadjuvant chemotherapy was completed on 6 February 2024, followed by right breast-conserving surgery and postoperative radiation (ypT1 ypN0/5). The patient was treated with ARAMIDEX and completed KADCYLA in November 2024. Ongoing hormonal therapy includes ZOLADEX, which was added in October 2025, and the patient remains on ARAMIDEX. Imaging in April 2026 demonstrated a BI-RADS 2 finding, and a breast ultrasound in June 2026 was unremarkable. The patient has a fatty liver noted on liver function testing and is receiving ZOMETA in conjunction with ZOLADEX and ARAMIDEX.

تحريرا في ,

التاريخ :	**19-09-2026**	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : **Rana Essam**

يعتمد ,

Patient Name	: [illegible]	Request No.	: 13004011
Patient No.	: 272120117015O6	Request Date	: 04/09/2023
Path No.	: SR-1003/23	Verification Date	: 11/09/2023
Sex	: Female	Financial Category	: [illegible]
Age	: 50 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical data
Right breast cancer&left breast adenosis

Nature of specimen
Revision of tru cut biopsy &IHC slides
Gross examination
Two block (203244/23)) + 3slides.

Microscopic examination
Right breast :
- Histological type: Invasive duct carcinoma
- Grade (differentiation +nuclear pleomorphism+mitosis): (3+2+2) Grade II
- DCIS: No
- Angioinvasion: Could not be detected within the limits of biopsy received

IPT :
ER:Moderate nuclear staining in 5% of tumor cells(4/8)
PR:Moderate nuclear staining in 60% of tumor cells (6/8)
Her2: Strong complete memrane staining in >10 of tumor cell , score(+3)
Left breast:
histopathological examination of sections prepared from the lumpectomy specimen received reveals diffuse stromal fibrosis and focal adenosis. Some of the proliferating ducts are irregularly dilated. The ducts are lined by inner columnar and outer myoepithelial cells. There is no evidence of malignancy in sections examined.
Diagnosis
1)
Righht breast mass ; slide revision of tru cut biopsy specimen :
Invasive duct carcinoma, Grade II .

Verified by :
Dr.Heba Hasan

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name	: الأستاذة / رانا سيد علي محمد	Request No.	: 13004011
Patient No.	: 272120117015O6	Request Date	: 04/09/2023
Path No.	: SR-1003/23	Verification Date	: 11/09/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اوراق على النسلام - فئة الدولة
Age	: 50 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

IPT :
ER: Positive (4/8)
PR:Positive (6/8)
Her2: Positive score(+3)
Left breast:
Fibroadenosis
Signature
Dr.Heba Hassan

Prof. Dr.Rana Fathy

Verified by :
Dr.Heba Hasan

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

(A)

Patient Name: Wafa Sagar Ali Mohamad — Date: 18/09/2023
Exam : C T ABDOMEN PELVIS — 58 Year(s)
Medical ID: 3351/2023

- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

Opinion:

- No signs of active pneumonia
- Calcular gallbladder.
- Left adnexeal cyst
- Hepatomegaly

DR. MOHAMMED MANSOUR

Signature Prof. Amr Farouk
18/09/2023 07:06 A
Dr. Amr Farouk, M.D.
Signature Prof. Amr Farouk
18/09/2023 08:23
Dr. Amr Farouk, M.D.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION AND DECISION SUPPORT

الهيئة العامة للتأمين الصحي

جهة الإصدار: فرع القنوات

تاريخ الإصدار: 2023-09-12

الرقم من جهة الأمر: .....

الهيئة العامة للتأمين الصحي تفعل من خلال قوانين منظمة لإشتراع المشمولين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "الزامي العاملة والمعاشات والزامي" وكذلك قانون 19 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 " الأطفال دون السن الإجباري" قانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالجراد المحمله ،

وفقاً لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعية

وفقاً لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعي

نحيطكم علماً أن/

البند (3) وفاء محمد علي محمد بطاقة رقم 27212011301506

وفقاً الى خطابكم من التأمينات الاجتماعية بالبند عدم الإشتراع

يعتبر من اللحظة عن المنتفع بالتأمين الصحي بصدور هذا الخطاب دون اى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحي خلال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحي الشامل

وتفضلوا

تاريخ الطباعة: 2023-09-12

الموظف المختص

منه الله طاهر

إدارة مركز نظم المعلومات

رقم المستند 1012693

الأمانة المركزية لشئون خدمة المنتفعين ودعم القرار

National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Wafaa Saeed Ali Mohamed	Date : 21/01/2024
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 51 Year(s)
Medical ID: 3351/2023	Pat. ID: 41657

Combined bilateral breast mammography and complementary ultrasound

Indication:

right breast pathgologically proven malignant mass on NACT for assessment.

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Dense breast parenchyma (ACR c)
- right breast shows UOQ clip seen.
- Complementary ultrasound revealed vanishing of right mass lesion was 3.7x4cm, in prior study.
- Stable left breast mass lesion of mixed echogenicity measures 12 x 25 mm.
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex of the left breast.
- Nonspecific axillary LN.
- Free infra and supra-clavicular regions.

Opinion:

- Good radiological response of the right breast UOQ malignant mass (BIRADS 6)
- Benign findings of left breast (BIRADS 2)

Yours truly

Dr.Wafaa Ali

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

MDT form

A-Patient ID:
1- Name : ولاء سعيد علي محمد
Sex: Female
2-ID number: 27212011701506
Medical number: 83161416
Old Med : 3351/2023
Patient Age : 51 Y

Family history: postive
Phone: 01012003466
BMI:
REASON OF MDT:
Marital status:
NRS Score:
GROUP:
Date of MDT: 10 / 03 / 2024
Co morbidity: NAD
Menopausal status:
Initial STAGE:

Clinical data

Breast Imaging :
RT UOQ 10 o'clock mass 42*28*29

Mets Workup :
CT chest : free
PAUS : Lt ovarium simple cyst
bone scan : free

BX	ER	PR	Her 2 Neu	SISH	KI67
IDC	4/8	6/8	3		
GII					

T	N	M
ct2	1	0

Sonomammography
rt breast uoq mass , path axillary lns
lt breast central mass biopsy fibroadenosis

PATIENT HISTORY
echo, labs
CESM THEN CLIP
FOR NEOADJ TCHP X6 CYCLES THEN BCS-SLN

MDT OUTCOME & PLAN

For Kadcyla *12 cycles .
Check E2 level and start Tamoxifen for 7 years then shift to AI
and PORT.

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	MEDICAL ONCOLOGY	RADIOLOGY	RADIOLOGY
SURGERY	SURGERY	PATHOLOGY	PATHOLOGY
Psychiatric	Psychiatric	Nutrition	Nutrition

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]